

11 - 11- Les urticaires - Pr. Hocar

Chers étudiants, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui ce cours intitulé « Les urticaires ». Donc, on va aborder tout ce qui est urticaire aiguë, la prise en charge de l'urticaire aiguë, soit qu'elle soit superficielle ou profonde, et puis les urticaires chroniques, l'enquête étiologique, comment l'amener et qui sont les étiologies les plus fréquentes d'une urticaire chronique. Les objectifs pédagogiques de ce cours sont, comme il suit, d'abord expliquer les mécanismes physiopathologiques de l'urticaire, diagnostiquer une urticaire aiguë, une urticaire chronique, conduire la démarche diagnostique à la recherche d'une étiologie de l'urticaire chronique le plus souvent, et puis évaluer les signes de gravité d'une urticaire, d'autant plus qu'elles soient profondes avec des signes ORL, reconnaître les différentes étiologies des urticaires chroniques, et bien sûr, énoncer les principes du traitement des urticaires de façon générale.

C'est quoi d'abord l'urticaire ? L'urticaire est une dermatose inflammatoire fréquente, son diagnostic repose sur l'interrogatoire et l'examen clinique. Il faut savoir que cette dermatose peut avoir une évolution aiguë, mais aussi chronique et récidivante, donc on parle d'une urticaire chronique quand elle dépasse six semaines d'évolution. Il s'agit d'un syndrome dont les causes peuvent être multiples, mais elles sont en pratique assez rarement retrouvées dans les formes chroniques.

Sur le plan physiopathologique, l'urticaire correspond à un oedème dermique, surtout dans le cadre d'une urticaire superficielle, au dermo-hypodermique dans le cadre des urticaires profonds, ou ce qu'on appelle aussi l'angio-oedème, et c'est dû à une vasodilatation avec augmentation de la perméabilité capillaire. Les modifications capillaires sont liées à des médiateurs inflammatoires, dont le principal est l'histamine. D'autres médiateurs peuvent également être impliqués, comme les leucocriens, les prostaglandins, le complément, les sérotonines, la citruline et autres.

Donc la liste ici n'est pas exhaustive, donc on peut distinguer deux mécanismes de l'apparition de l'urticaire. D'abord un mécanisme immunologique nécessitant une sensibilisation préalable, comme c'est le cas d'hypersensibilité immédiate de type anaphylactique, médiée par les immunoglobulines E ou les immunoglobulines G4. Hypersensibilité par activation du complément ou dans le cadre d'une urticaire par vascularité, donc une urticaire par vascularité caractérisée par des papules fixes qui restent sur place pendant au moins 24 heures et qui sont dans le cadre d'une maladie de système.

Il y a un autre mécanisme qui est immunologique, mécanique ou pharmacologique et c'est dû à un apport direct aux libérations de l'histamine, souvent les aliments riches en histamines, le fromage ou les histamino-libérateurs des crustacés. C'est dû aussi à un défaut d'inhibition de médiateurs comme l'alpha-1-antitrypsine, c'est une estérase qui donne l'oedème angioneurétique par déficit en inhibiteur de C1-estérase qui est souvent génétique. Et puis il y a l'urticaire

cholénergique, médiée par la libération de l'acidoculine dans certaines circonstances, notamment les formes et les émotions.

Là c'est un schéma qui illustre la papule oedémateuse urticarienne de sièges dermiques. Il faut noter que toutes les urticaires ne relèvent pas d'un mécanisme allergique, il n'est même immunologique. La plupart des urticaires chroniques relèvent d'un mécanisme non allergique.

L'origine allergique d'une urticaire aiguë et a suspecté ses lésions surviennent dans les minutes ou au maximum dans un délai de deux heures après l'ingestion d'un aliment ou d'un médicament. Passé ce délai, l'origine allergique est très peu probable. Les urticaires par vascularite ou vasculite ont des caractéristiques cliniques particulières, elles sont fixes, c'est-à-dire ces lésions qui sont fixes ne bougent pas, et l'absence de prurite qui est souvent absente quand on voit les patients, on leur demande s'ils se grattent, ils disent que c'est un prurite qui est discret ou même il n'y a pas de prurite.

Et si on voit ça, on doit penser à l'urticaire par vasculite. Sur le plan clinique, l'urticaire peut avoir plusieurs tableaux. D'abord, le tableau d'urticaire superficiel commun, d'ailleurs c'est la forme la plus fréquente et la plus commune.

Le diagnostic clinique est en général facile, les papules aux plaques érythémateuses, aux rosées, aux ortiers, aux oedémateuses, abordées en trois caractéristiques symbiologiques majeures des urticaires communes qui sont non liées à un mécanisme de vascularite ou de vasculite. D'abord, ce sont des papules fugaces, ça veut dire que chaque lésion élémentaire disparaîtra au moins de 24 heures, elles sont migratrices, c'est-à-dire elles bougent d'un endroit à l'autre, elles sont prurigineuses, c'est-à-dire que le patient se gratte et rapporte un prurite associé à ces lésions. Dans le cadre d'une urticaire commune superficielle, la biopsie cutanée n'est pas nécessaire au diagnostic et n'est justifiée qu'en cas de suspicion d'urticaire par vascularite, ça veut dire les lésions qui sont fixes et qui sont peu ou pas prurigineuses.

Deuxième tableau qu'on peut rencontrer dans le cadre d'urticaire, ce sont les urticaires profondes ou appelées aussi angio-oedèmes ou oedèmes de Quincke. Donc l'oedème est épidermique, ça veut dire qu'il est profond, il peut toucher la peau ou même les muqueuses et peut être isolé ou associé à une urticaire superficielle. L'angio-oedème réalise une tuméfaction ferme, mal limitée, ni érythémateuse, ni prurigineuse qui provoque une sensation de tension douloureuse au visage.

L'angio-oedème touche préférentiellement les paupières et les lèvres. On peut avoir aussi d'autres formes cliniques de ces urticaires, mais avant, les localisations muqueuses de la sphère ORL conditionnent le pronostic dans le cadre d'une urticaire profonde. L'apparition d'une dysphonie, d'une hypersalivation par trouble de la ventilation est un signe d'alarme qui peut précéder l'asphyxie si l'oedème siège sur la glotte.

Donc l'oedème de Quincke peut être le signe d'un choc anaphylactique de l'intérêt de le déclarer

comme une urgence thérapeutique et diagnostique. Il existe d'autres formes d'urticaire, notamment surtout les formes d'urticaire superficielle qui peut être accompagnée de lésions papuleuses, cercinées, artiformes, petites plaques, ocropuses et donc plusieurs tableaux peuvent se rencontrer lors d'une urticaire cutanée. Voici une patiente jeune qui présente une urticaire toute simple avec des lésions cercinées, prurigineuses, diffuse sur toute la peau, secondaire à une prise médicamenteuse.

Là vous voyez un oedème de la langue qui se voit dans les suites d'un oedème de cuic et il faut noter, comme je viens de vous le dire, la localisation muqueuse de la sphère ORL, condition de pronostic vital, donc c'est une urgence thérapeutique. Ça c'est dans le cadre d'une urticaire profonde d'origine médicamenteuse. C'est un patient qui est connu allergique au bêtalactamine, il a un oedème de cuic.

Ce que vous voyez ce sont des plaques d'urticaire à contour géographique, vraiment c'est des grandes plaques qui dépassent les 20 centimètres et sont par endroits annulaires, coalescentes. J'ai une personne qui présente une urticaire aiguë. Voici une photo d'une autre personne qui présente ce qu'on appelle une urticaire propulse.

On ne distingue même pas l'aspect de la peau saine, donc c'est des plaques vraiment coalescentes, diffuse sur une surface cutanée très importante et bien sûr c'est une forme clinique d'une urticaire commune simple, superficielle. Là pour vous montrer l'aspect d'un dermatographisme, c'est quand le patient gratte ou on peut le reproduire par le frottement, par un abaisse-langue ou même un objet qui va un petit peu tracer une ligne sur la peau et on va avoir la reproduction des lésions papuleuses linéaires de l'urticaire. C'est un signe aussi élémentaire dans le cadre de l'urticaire à côté des papules qu'on peut reproduire à la consultation si le patient se présente et n'a pas de lésions urticariennes.

Donc là c'est une personne qui présente un OEDEM pas fébral dans le cadre d'une urticaire profonde post-médicamenteuse. Sur le plan évolutif, on distingue majoritairement deux grandes formes, les formes aiguës dans l'évolution inférieure à six semaines et les formes chroniques ou récidivantes avec une durée d'évolution au-delà de six semaines. Le diagnostic étiologique est vraiment obligatoire surtout dans les formes chroniques de l'urticaire.

Généralement dans les formes aiguës, si on vous mène à l'interrogatoire, à un examen clinique et qu'on ne trouve pas d'étiologie, on peut traiter sans faire d'investigation paraclinique. Mais là dans le cadre d'une urticaire chronique, il faut obligatoirement mener un interrogatoire minutieux, un examen clinique, s'on ne trouve pas, c'est en absence d'orientation étiologique clinique, il faut recommander un bilan d'urticaire chronique. On peut proposer un traitement avant, à base d'antihistaminiques et puis les examens complémentaires doivent comprendre au minimum une numération formule sanguine, une vitesse de sédimentation, une recherche d'anticorps antithéropoxydase et une électrophorese des protéines sanguines.

Donc ce sont des éléments à prescrire et à associer à un traitement antihistaminique dans le cadre d'une urticaire chronique. D'autres investigations peuvent se faire, toujours dans le cadre d'une urticaire chronique, si on suspecte une urticaire physique ou une urticaire allergique, comme des tests allergologiques, cutanés, les tests physiques comme des tests glaçants, tests panéthropes, dans le cadre d'urticaire cholinergiques. On arrive aux étiologies, la plupart des causes sont évoquées par l'interrogatoire et l'examen clinique, mais on peut aussi trouver des éléments en faveur de l'urticaire physique.

C'est l'étiologie la plus fréquente des urticaire chroniques et ces urticaire sont déclenchées par des stimulus physiques de la peau et sont confirmées par des tests physiques réalisés après arrêt de traitement anti-stimulique au moins 4 jours auparavant, donc souvent sont déclenchées par friction, pression, froid, chaleur et solaire. Première forme d'urticaire physique, ce sont les dermatographismes, il peut être isolé ou associé à une urticaire banale et les deux causes inconnues, son évolution peut être très prolongée, il est déclenché par la friction cutanée et se traduit par l'hystérie urticarienne, oedémateuse, orthie, on regarde des lésions de drapage et peut-être reproduit par le frottement à l'aide d'une pointe mousse, on distingue les formes rouges, vraies et retardées, donc les formes retardées apparaissent entre 1 et 8 heures et persistent à 2 jours. Voici l'aspect d'un dermatographe qu'on a provoqué en consultation.

Deuxième forme d'urticaire physique, c'est l'urticaire retardé à la pression, il entraîne un oedème dermique et cutané douloureux, surmulant le plus souvent 3 à 12 heures après une forte pression, plantes après une longue marche, niveau plantaire, les fesses après une station assise prolongée et au niveau du palmar après le port d'un sac et ça peut être reproduit par l'apparition des lésions après le port durant 20 minutes, d'un poids de moins 6 kilos sur l'épaule, le bras ou la cuisse, la lecture du test au poids doit être tardive. On arrive au deuxième tableau, enfin le troisième tableau, c'est l'angioedème vibratoire, c'est une forme d'urticaire physique très rare et ça se développe sous forme d'une urticaire profonde, secondaire à des stimuli vibratoires comme le marteau cliqueur et les appareils électroménage. Une autre forme d'urticaire physique c'est l'urticaire au froid, il touche typiquement les mains et le visage, les circonstances déclenchantes sont variées, l'eau froide, l'air froid, la pluie, la neige, les baignades, le diagnostic repose sur la reproduction des lésions par le test au glaçon ou sous-surveillance hospitalière par l'immersion du bras dans l'eau glacée.

Donc ça peut aussi être dans le cadre d'urticaire familiales au froid ou d'urticaire généralisées au froid, donc cet urticaire est le plus souvent idiopathique ou parfois lié à une virose mais doit faire rechercher une dysglobulinémie, une cryoglobulinémie, une cryofibrinogénémie ou des agglutinines froides. Cet urticaire impose de se protéger du froid, d'éviter les aliments glacés et de prendre beaucoup de précautions lors des baignades où le risque de malaise est très important. À côté des urticaire au froid, on peut avoir aussi des urticaire au chaud, ça englobe trois formes, donc l'urticaire polynergique représente 5 à 10%, donc il est déclenché par la chaleur, la sudation, les émotions et les efforts, leur durée excèdera rarement 30 minutes, le

diagnostic est confirmé par le test des formes en atmosphère chaude qui va reproduire des lésions qui sont des micropapules, pas les vrais papules urticariennes caractéristiques de l'urticaire polynergique.

Il y a aussi l'urticaire solaire qui est exceptionnel, il survient dans les premières minutes d'une exposition à la lumière visible et aux ultraviolets sur les zones habituellement couvertes et disparaît en moins d'une heure après la mise à l'ombre, elle peut être très invalidante lorsque le seuil de déclenchement est bas et nécessite une prise en charge spécialisée, on peut avoir aussi l'urticaire de contact à la chaleur aussi, donc dès qu'on touche une source chaude, on peut avoir de l'urticaire. Pour vous montrer l'aspect des papules, des micropapules, c'est des petites lésions de petite taille éparpillées secondaire à une urticaire polynergique. Toujours dans les urticaires physiques, il y a l'urticaire aquagénique, il est rare, il se déclenche lors du contact avec l'eau, les lésions élémentaires ressemblent à celles de l'urticaire polynergique, il est reproduit par l'application sur la peau d'une peau presse mouillée à 37 degrés pendant 30 minutes.

Là pour vous montrer le test qu'on fait pour reproduire l'urticaire aquagénique, on applique de l'eau sur la peau et puis on la laisse pendant 30 minutes à une température de 37 degrés Celsius pour voir si le patient va reproduire les lésions d'urticaire. Voilà l'aspect de lésions urticariennes reproduites par le test d'application sur la peau de l'eau à 37 degrés pendant 30 minutes, caractéristique de l'urticaire aquagénique. Nous arrivons aux urticaires de contact et peuvent être de mécanismes immunologiques et géodépendants comme l'urticaire de contact latex aux aliments et aux médicaments ou non immunologiques secondaires au contact avec des plantes urticariantes ou comme les orties, les méduses, les chenilles.

Les lésions apparaissent rapidement, moins de 30 minutes avec les protéines allergisantes mais peuvent se généraliser secondairement avec risque de choc anaphylactique et le diagnostic est confirmé par test ouvert ou pris de test fait sous haute surveillance. L'allergie au latex est de plus en plus fréquente en particulier chez le personnel de santé, personnel soignant. Les sujets atopiques et les malades mutuoopérés présentent ce genre d'urticaire de contact.

Cette sensibilisation est à l'origine d'accidents préopératoires liés au contact avec les gants de caoutchouc de chirurgien. La recherche d'une obliviouse spécifique au RASP et surtout les prises de test confirment ce genre d'urticaire de contact. Cette photo montre une personne qui a eu de l'urticaire de contact de caoutchouc sur ses cuisses suite à une position assise sur un fauteuil qui contient une substance liée au caoutchouc.

À noter le caractère qui trace la zone de contact et les lésions sont souvent papilleuses pour les différenciés d'un eczéma de contact. Les urticaires médicamenteuses, il s'agit d'une cause assez fréquente, l'urticaire aigu, le plus rarement l'urticaire chronique, souvent les ANS, les enzymes de conversion. Dans les urticaires médicamenteuses d'origine allergique, les lésions apparaissent dans les minutes ou les heures qui suivent la prise du médicament.

Dans les urticaires non allergiques comme l'angio-odème dû aux enzymes de conversion, les lésions peuvent apparaître après plusieurs jours ou voire plusieurs semaines de traitement. Les urticaires médicamenteuses sont plus sensibles aux traitements anti-allergiques et sont de résolution plus lente que dans d'autres urticaires allergiques. De nouvelles lésions peuvent ainsi apparaître pendant plusieurs jours malgré l'arrêt du médicament responsable.

L'urticaire médicamenteuse peut révéler de différents mécanismes, un mécanisme qui nécessite une sensibilisation préalable, mais aussi un mécanisme non allergique, on dit mécanisme pharmacologique, ou un mécanisme par staminolibération non spécifique comme la codéine par exemple, ou par accumulation de métabolites pro-inflammatoires comme l'intolérance à l'aspirine et aux ANS par exemple. Un grand nombre d'urticaires chroniques et idiopathiques est ainsi aggravé par la prise d'aspirine ou par la prise d'antiafflammatoires non stéroïdiens. Cet encadré présente les principaux médicaments responsables d'une urticaire, d'abord les bétalactamides, les anesthésiques selon les plus rares, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les produits de contraste COD, des sérums et vaccins, mais tous les médicaments peuvent être en cause de l'intérêt d'un interrogatoire minutieux avant de prescrire tout type de médicament.

De très nombreux aliments, mais également des additifs et des conservateurs peuvent être impliqués dans l'urticaire aigu et plus rarement chronique. Au cours de l'urticaire chronique, il s'agit le plus souvent d'une pseudo-allergie alimentaire par un mécanisme non immunologique. Ça veut dire que l'aliment ici est histamino-libérateur, riche en histamine ou en tyramine consommée en grande quantité comme les crustacés, le thon, le fromage et les ferments.

Parfois il s'agit d'une allergie vraie, médiée par les AGE, le plus souvent en cause dans les urticaires aiguës que dans les urticaires chroniques. Dans l'allergie alimentaire vraie, l'urticaire survient rapidement après l'ingestion, quelques minutes à deux heures de l'aliment en cause. La responsabilité de l'aliment doit être mise en doute au-delà d'un délai de trois heures.

Le diagnostic repose sur l'interrogatoire, l'analyse du pays alimentaire, le dosage désigné spécifique d'un aliment type A, les prix de test et l'effet d'un régime d'éviction. Le test de réintroduction milieu-hospitalier permet de confirmer le ou les aliments responsables. En cas d'allergie alimentaire vraie, l'éviction la plus souvent définitive de l'allergène en cause est nécessaire, comme l'allergie aux crevettes ou aux fraises.

En cas de pseudo-allergie alimentaire, une simple correction du régime alimentaire évitant les apports trop importants d'un aliment histaminolibérateur est habituellement suffisant. La plupart des virus comme l'hépatite B, la mononucléose infectieuse, le C-terme omégalo virus, sont des causes classiques d'urticaires le plus souvent aigus. Les parasitoses comme la giardiase, l'ascaridiase, la toxocarose, sont plutôt responsables du urticaire chronique.

En cas de symptomatologie clinique évocatrice ou liée aux ionophilies sur l'annumération formée

sanguine, faire un examen parasitologique baisselle est au haut des sérologies. Hormis pour les angiodèmes, cervicopatios, récidivons, la responsabilité d'employer infections ORL ostomatologiques comme le granulomata, dans les urticaires chroniques idiopathiques, est une notion ancienne qui ne repose que sur quelques observations isolées témoignant de l'association probablement fortuite. Surtout, il faut chercher les parasitoses intestinales et les maladies fongiques qui peuvent donner des urticaires de cause infectieuse.

Nous arrivons à des formes cliniques chroniques particulières, ce sont les urticaires génétiques ou l'odème congénoritique héréditaire. Il est lié à un déficit quantitatif ou plus rarement qualitatif en inhibiteur de la C1 estérase et se traduit par des épisodes récidivants d'angio-odème sans urticaire superficielle. Les épisodes sont évocateurs lorsqu'ils respectent l'hippopièrè et prédominent aux extrémités ainsi qu'aux organes génitaux externes.

Le pronostic est conditionné par l'atteinte laryngée, l'atteinte digestive fréquente et trompeuse à type de douleur abdominale ou de syndrome pseudo-occlusif est souvent révélatrice. La notion de facteurs déclenchants est très évocatrice, en particulier les traumatismes comme la chirurgie, l'endoscopie et certains médicaments dans les oestrogènes. La plupart des cas sont héréditaires avec une transmission autosomique dominante, mais il existe de rares formes acquises secondaires à des myoplasies ou à une consommation par des infections.

Le diagnostic repose sur le dosage du C1 inhibiteur et des fractions C2 et C4 du complément qui sont abaissées alors que le C3 est normal et le traitement prophylactique s'il y a plus d'une crise par mois et le suivant, ça donne intérêt à l'androgène dans la zone où la site trans examique en cas de contre-indication et le traitement de crise souvent aussi la site trans examique en cas de crise peu importante et en cas de crise grave, il faut hospitaliser et perfuser le C1 inhibiteur purifié et où la pharmacothérapie apporte d'autres. Une autre forme d'urticaire génétique plus rare c'est le syndrome de Michael Lewis. C'est une urticaire génétique de transmission autosomique dominante caractérisée par des plaques urticariennes de la pierre au moment de l'épisode, une surdité de perception progressive et bien sûr qu'il pourrait être une amylose rénale retardée inconsciente.

On peut avoir des plaques urticariennes fixes qu'on appelle les urticaires systémiques. Ce sont des urticaires caractérisées par des lésions qui sont fixes, ne sont pas migratrices, ne sont pas fugaces, qui persistent au-delà de 24 heures au même endroit. Le prurite est peu important ou même absent et souvent caractéristique d'une maladie de système comme le lupus, l'hérétématosystémie, les polyarthrites, l'hématoïde, la maladie de l'hostile et les disques de willy-nilly.

On peut caractériser certaines formes d'urticaires idiopathiques, c'est-à-dire c'est des urticaires qu'on n'a pas pu cadrer ou leur trouver une étiologie, donc on les appelle les urticaires idiopathiques. Ils sont fréquents dans 50 à 75 % des cas. Est-ce que c'est des urticaires alimentaires qu'on n'a pas pu trouver l'aliment responsable où il y a des facteurs psychogènes,

notamment le stress, dans l'apparition de ces urticaires idiopathiques? Le traitement généralement quand il s'agit d'une urticaire aiguë, il faut proposer des antihistaminiques type 1, l'éviction de la cause et des corticoïdes si on a des formes sévères.

Quand il s'agit d'une urticaire chronique commune, il faut proposer un traitement étiologique et des antihistaminiques pour améliorer la qualité de vie des patients. En cas d'une urticaire profonde ou d'un oedème de puic, il faut proposer l'adrénaline, ses gènes l'arranger en aérosol et ses disponés, on peut la proposer en intramusculaire. L'oxygénothérapie bien sûr et l'hospitalisation en réanimation, on peut être amené à proposer des corticoïdes parfois intramusculaires ou intraveineuses ou des antihistaminiques parfois intraveineuses ou intramusculaires.

Comme je vous l'ai dit, en cas d'un oedème héréditaire, le traitement prophylactique se base sur les androgènes, le type d'anazole qui n'est pas disponible au Maroc, mais aussi de l'acide trans-examique, l'hexacide en cas de contre-indication. Si crise sévère, on hospitalise les patients pour qu'ils utilisent le C1-inhibiteur purifié à partir d'un plasma humain. Là c'est une diapo qui récapitule tout ce qu'on a vu, la physiopathologie, le diagnostic clinique, les étiologies d'une urticaire, les démarches diagnostiques avec le bilan à demander si on ne trouve pas d'étiologie après l'interrogatoire et l'examen clinique, et les traitements à proposer en monothérapie puis la biothérapie en cas de persistance de l'urticaire.

Au final, l'urticaire c'est un syndrome plutoniumique peu inflammatoire, peu réigneux, caractérisé par un oedème localisé au niveau du derme. Les causes comme on l'a vu sont diverses, l'urticaire physique, l'urticaire alimentaire, médicamenteuse, infectieuse et la recherche étiologique sont difficiles et nécessitent une patience et de la tonacité. Je vous remercie pour votre attention.